Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 3 · octobre 2026
p. 72–75 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT

Les outils d'IA dans la pratique clinique quotidienne

Documentation, psychoéducation et soutien entre les séances au regard du consentement, de la protection des données et de la responsabilité professionnelle

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

L'intelligence artificielle (IA) générative est passée des laboratoires de recherche au quotidien des psychothérapeutes et des conseillers, souvent plus vite que ne se sont développées les recommandations professionnelles. Cet article de pratique examine trois domaines dans lesquels des outils d'IA sont utilisés ou proposés dans le travail clinique quotidien : la documentation clinique, la préparation de matériel psychoéducatif et le soutien des patients entre les séances. Pour chaque domaine, nous esquissons des bénéfices plausibles, tels qu'une charge administrative réduite et des informations mieux adaptées, et décrivons des risques caractéristiques, notamment des contenus inventés, des distorsions du sens clinique et le transfert de données sensibles à des prestataires externes. Nous examinons ensuite le cadre normatif dans lequel de tels outils doivent être utilisés : un consentement éclairé spécifique et révocable, les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) concernant les données de santé, les nouvelles obligations du règlement européen sur l'IA et la responsabilité professionnelle durable du clinicien pour chaque document et chaque intervention. En nous appuyant sur les données relatives à la santé mentale numérique et sur des analyses éthiques de l'IA en psychothérapie, nous formulons des recommandations pratiques pour les cliniciens et les institutions. Dans une perspective centrée sur le sens, nous soutenons que l'IA peut décharger les cliniciens de certaines tâches, mais non de leur responsabilité, qui demeure au cœur de la pratique professionnelle.

Mots-clés : intelligence artificielle · documentation clinique · soutien entre les séances · consentement éclairé · protection des données

ABSTRACT

Generative artificial intelligence (AI) has moved from research laboratories into the daily routines of psychotherapists and counselors, often faster than professional guidance has developed. This practice paper examines three areas in which AI tools are used or proposed in everyday clinical work: clinical documentation, the preparation of psychoeducational material, and support for patients between sessions. For each area, we outline plausible benefits, such as reduced administrative burden and more tailored information, and describe characteristic risks, including fabricated content, distortions of clinical meaning, and the transfer of sensitive data to external providers. We then discuss the normative framework within which such tools must be used: informed consent that is specific and revocable, the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) for health data, the emerging obligations of the EU AI Act, and the enduring professional responsibility of the clinician for every document and intervention. Drawing on evidence from digital mental health and on ethical analyses of AI in psychotherapy, we formulate practical recommendations for clinicians and institutions. From a meaning-centered perspective, we argue that AI can relieve clinicians of tasks but not of responsibility, which remains at the core of professional practice.

Keywords: artificial intelligence · clinical documentation · between-session support · informed consent · data protection

1 Introduction

En quelques années, les grands modèles de langage (large language models, LLM) sont devenus accessibles à toute personne disposant d'un navigateur. Les cliniciens les rencontrent désormais sous forme d'offres concrètes : des logiciels qui rédigent des notes de séance, des assistants qui résument des rapports et des chatbots que les patients

utilisent de leur propre initiative. Des revues antérieures consacrées à la psychiatrie numérique décrivaient un domaine composé d'applications, de programmes délivrés par Internet et de premiers agents conversationnels, dont la base de preuves était inégale et dont la mise en œuvre accusait un retard sur le développement technique (Torous et al., 2021). L'IA générative accentue cet écart : les outils sont plus performants et plus largement disponibles, mais les recommandations professionnelles, les politiques institutionnelles et les connaissances empiriques sur leur utilisation dans les soins courants restent limitées (Stade et al., 2024).

Cet article de pratique s'adresse aux cliniciens qui envisagent d'utiliser des outils d'IA dans leur travail quotidien ou qui les utilisent déjà. Il n'évalue pas de produits commerciaux particuliers, dont les fonctionnalités évoluent rapidement, mais décrit des cas d'usage typiques et les questions qu'ils soulèvent. Nous nous concentrons sur la documentation, la psychoéducation et le soutien entre les séances, avant d'aborder le consentement éclairé, la protection des données et la responsabilité professionnelle. L'objectif n'est ni de promouvoir ni de décourager l'usage de l'IA, mais de soutenir une pratique réfléchie, transparente et responsable.

2 Documentation et soutien administratif

La documentation constitue un point d'entrée plausible, car elle est chronophage, en partie standardisée et souvent vécue comme éloignée du travail thérapeutique proprement dit. Les outils fondés sur les LLM peuvent transformer des mots-clés en notes lisibles, structurer des rapports destinés aux organismes payeurs ou aux médecins adresseurs, ou résumer des dossiers antérieurs. Certains produits enregistrent en outre les séances et génèrent des notes à partir des transcriptions. Leurs promoteurs en attendent un gain de temps et une charge administrative moindre, bien que des preuves solides de tels effets en psychothérapie restent rares (Stade et al., 2024).

Les risques sont propres à la technologie. Les modèles de langage produisent des textes fluides sur la base de régularités statistiques et peuvent générer des énoncés plausibles mais non étayés par les données d'entrée, un phénomène désigné sous le nom d'hallucination (Ji et al., 2023). Dans un dossier clinique, un symptôme inventé, un propos mal attribué ou une ambivalence aplanie ne constituent pas un défaut stylistique, mais une erreur de documentation susceptible d'avoir des conséquences pour le diagnostic, le traitement et les procédures juridiques. En outre, les modèles entraînés sur de vastes corpus textuels peuvent reproduire des stéréotypes présents dans leurs données d'entraînement (Bender et al., 2021), ce qui peut se refléter dans la manière dont le comportement, la culture ou l'identité d'un patient sont décrits.

Une autre préoccupation est moins visible. La rédaction de notes n'est pas seulement un acte administratif, mais aussi un moment de réflexion au cours duquel les cliniciens organisent leurs impressions et formulent des hypothèses. Si la rédaction est entièrement déléguée, cette fonction réflexive risque de s'affaiblir. Une pratique prudente utilise donc l'IA pour la mise en forme et la révision linguistique de contenus que le clinicien a déjà formulés, plutôt que pour produire des évaluations cliniques, et considère chaque brouillon comme une proposition à vérifier ligne par ligne.

3 Psychoéducation et soutien entre les séances

La psychoéducation se prête à l'assistance par l'IA, car elle consiste en grande partie à expliquer des concepts bien établis dans un langage accessible. Les cliniciens peuvent recourir aux LLM pour rédiger des fiches d'information sur l'hygiène du sommeil, le cercle de l'évitement dans l'anxiété ou la justification de l'activation comportementale, et les adapter au niveau de lecture ou à la langue préférée d'un patient. De tels brouillons peuvent faire gagner du temps, mais ils exigent une relecture attentive, car les explications générées peuvent être obsolètes, simplifiées à l'excès ou subtilement inexactes (Ji et al., 2023). Le clinicien demeure responsable du matériel écrit remis à un patient autant que de tout ce qui est dit en séance.

Le travail entre les séances est une composante centrale de nombreux traitements, et des données méta-analytiques suggèrent que les tâches à domicile sont associées à de meilleurs résultats dans les thérapies cognitives et comportementales (Kazantzis et al., 2010). Les traitements délivrés par Internet, avec des degrés variables d'accompagnement par un thérapeute, ont accumulé une base de preuves substantielle (Andersson et al., 2019). Les agents conversationnels en représentent une forme plus récente : un essai précoce portant sur un chatbot à base de règles a rapporté des réductions à court terme des symptômes dépressifs (Fitzpatrick et al., 2017), et un premier essai randomisé portant sur un chatbot d'IA générative a rapporté des améliorations symptomatiques par rapport à une condition de liste d'attente (Heinz et al., 2025). Ces résultats sont

encourageants, mais limités par des périodes de suivi courtes, des échantillons sélectionnés et des conditions de comparaison qui ne permettent pas de conclure à une valeur ajoutée par rapport aux interventions établies.

Pour la pratique clinique, il importe de savoir si un outil est intégré au traitement ou utilisé de manière autonome par le patient. Lorsque les cliniciens recommandent une application fondée sur l'IA, ils devraient connaître sa finalité, sa gestion des situations de crise et ses pratiques en matière de données. Une étude précoce a montré que des assistants pour smartphone largement utilisés répondaient de manière incohérente et souvent inadéquate à des énoncés portant sur des idées suicidaires, la dépression et la violence (Miner et al., 2016). Les systèmes actuels diffèrent considérablement, mais la gestion des crises doit toujours être testée plutôt que présumée. Il est tout aussi important de demander ouvertement aux patients s'ils utilisent déjà des chatbots généralistes pour obtenir un soutien émotionnel, car un tel usage n'est souvent pas mentionné spontanément.

4 Consentement éclairé et protection des données

Tout usage de l'IA impliquant des informations relatives aux patients requiert un fondement juridique et éthique clair. En vertu du RGPD, les données concernant la santé font partie des catégories particulières de données à caractère personnel, dont le traitement n'est autorisé que dans des conditions strictes (European Parliament & Council of the European Union, 2016). Saisir des contenus de séance identifiables dans un chatbot accessible au public revient généralement à transférer des données de santé à un tiers, souvent en dehors de l'Union européenne, sans base juridique adéquate ni contrat de sous-traitance. Même des notes apparemment anonymisées peuvent permettre une réidentification lorsqu'elles sont combinées à des éléments de contexte.

Dans ce contexte, le consentement éclairé devrait être spécifique plutôt que général. Les patients devraient savoir quel outil est utilisé, dans quel but, quelles données sont traitées et où, si les données servent à entraîner des modèles, et qu'un refus n'a aucune conséquence pour leur traitement. Le consentement devrait être documenté et révocable. Les analyses éthiques de l'IA en psychothérapie ont souligné la transparence envers les patients, l'attention portée aux groupes vulnérables et la clarté quant aux limites de la technologie (Fiske et al., 2019). Le règlement européen sur l'IA ajoute des obligations de transparence, par exemple l'obligation d'informer les personnes lorsqu'elles interagissent avec un système d'IA, et impose des exigences plus strictes aux systèmes classés à haut risque (European Parliament & Council of the European Union, 2024). Les cliniciens n'ont pas à devenir juristes, mais ils devraient savoir si leurs outils et leurs institutions satisfont à ces exigences.

5 Responsabilité professionnelle et jugement clinique

Les codes de déontologie professionnelle ne perdent pas leur validité du fait qu'une tâche est assistée par un logiciel. Les obligations de compétence, de confidentialité et de non-malfaisance s'appliquent à chaque document signé et à chaque recommandation formulée (American Psychological Association, 2017). Luxton (2014) avait anticipé que l'IA soulèverait des questions de compétence et de responsabilité dans la pratique psychologique, y compris la nécessité pour les cliniciens de comprendre les capacités et les limites des systèmes qu'ils utilisent. Avec l'IA générative, dont les productions varient selon la formulation, la version du modèle et le contexte, cette exigence devient pressante.

Un risque spécifique est le biais d'automatisation, c'est-à-dire la tendance à accepter des suggestions produites par une machine avec moins d'esprit critique que son propre raisonnement. Un brouillon bien formulé peut paraître plus convaincant qu'il ne le mérite. La logothérapie décrit la responsabilité comme un trait constitutif de l'existence humaine : c'est la personne qui doit répondre aux exigences d'une situation concrète (Frankl, 1946/1985). Appliqué à la pratique professionnelle, cela suggère un principe simple : l'IA peut prendre en charge des tâches, mais non la responsabilité. Le clinicien qui reprend une phrase dans un rapport en répond comme si elle était la sienne.

6 Recommandations pratiques

Plusieurs recommandations en découlent pour la pratique individuelle. Premièrement, aucune donnée identifiable relative aux patients ne devrait être saisie dans des outils dépourvus de contrat de sous-traitance conforme au RGPD et d'informations transparentes sur le lieu de stockage et l'utilisation des données à des fins d'entraînement. Deuxièmement, les brouillons de notes, de rapports et de matériel d'information générés par l'IA devraient être intégralement relus et corrigés avant utilisation ; les diagnostics et les évaluations du risque devraient être formulés par le

clinicien. Troisièmement, les patients devraient être informés dans un langage compréhensible et invités à donner leur consentement explicite chaque fois que leurs données sont traitées par des outils d'IA.

D'autres recommandations concernent le traitement et les institutions. Quatrièmement, les applications recommandées pour l'usage entre les séances devraient être choisies sur la base des preuves disponibles, de protocoles de crise transparents et de leurs pratiques en matière de données, et leur utilisation devrait être discutée en séance. Cinquièmement, les cliniciens devraient s'enquérir systématiquement de l'usage autonome de chatbots par les patients et en explorer la signification sans le dévaloriser. Sixièmement, les institutions devraient adopter des politiques écrites précisant les outils autorisés, les finalités admises et les responsabilités, et proposer des formations. La recherche sur la santé mentale numérique a montré que la mise en œuvre dépend non seulement de la technologie, mais aussi des conditions organisationnelles et de l'adéquation aux processus cliniques (Mohr et al., 2017) ; il est peu probable que les outils d'IA fassent exception.

7 Conclusion

Les outils d'IA peuvent réduire la charge administrative, soutenir la préparation de matériel psychoéducatif et prolonger le travail thérapeutique dans l'intervalle entre les séances. Ces potentiels sont réels, mais ils s'accompagnent de risques de contenus inventés, d'usage abusif des données et d'une érosion de la réflexion professionnelle. La question décisive pour la pratique quotidienne n'est donc pas de savoir si l'IA est utilisée, mais comment : de manière transparente, avec un consentement éclairé, dans le respect du droit de la protection des données et sous l'entière responsabilité du clinicien. Ainsi utilisée, l'IA peut décharger les cliniciens de certaines tâches et laisser davantage de place à ce qui demeure leur véritable travail : la rencontre avec une personne en quête de sens.

Références

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct (2002, amended effective June 1, 2010, and January 1, 2017). https://www.apa.org/ethics/code

Andersson, G., Titov, N., Dear, B. F., Rozental, A., & Carlbring, P. (2019). Internet-delivered psychological treatments: From innovation to implementation. World Psychiatry, 18(1), 20–28. https://doi.org/10.1002/wps.20610

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

European Parliament & Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 1–88.

European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L, 2024/1689.

Fiske, A., Henningsen, P., & Buyx, A. (2019). Your robot therapist will see you now: Ethical implications of embodied artificial intelligence in psychiatry, psychology, and psychotherapy. Journal of Medical Internet Research, 21(5), e13216. https://doi.org/10.2196/13216

Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. JMIR Mental Health, 4(2), e19. https://doi.org/10.2196/mental.7785

Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning (Rev. ed.). Washington Square Press. (Original work published 1946)

Heinz, M. V., Mackin, D. M., Trudeau, B. M., Bhattacharya, S., Wang, Y., Banta, H. A., Jewett, A. D., Salzhauer, A. J., Griffin, T. Z., & Jacobson, N. C. (2025). Randomized trial of a generative AI chatbot for mental health treatment. NEJM AI, 2(4). https://doi.org/10.1056/AIoa2400802

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Kazantzis, N., Whittington, C., & Dattilio, F. (2010). Meta-analysis of homework effects in cognitive and behavioral therapy: A replication and extension. Clinical Psychology: Science and Practice, 17(2), 144–156. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2010.01204.x

Luxton, D. D. (2014). Artificial intelligence in psychological practice: Current and future applications and implications. Professional Psychology: Research and Practice, 45(5), 332–339. https://doi.org/10.1037/a0034559

Miner, A. S., Milstein, A., Schueller, S., Hegde, R., Mangurian, C., & Linos, E. (2016). Smartphone-based conversational agents and responses to questions about mental health, interpersonal violence, and physical health. JAMA Internal Medicine, 176(5), 619–625. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.0400

Mohr, D. C., Weingardt, K. R., Reddy, M., & Schueller, S. M. (2017). Three problems with current digital mental health research . . . and three things we can do about them. Psychiatric Services, 68(5), 427–429. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201600541

Stade, E. C., Stirman, S. W., Ungar, L. H., Boland, C. L., Schwartz, H. A., Yaden, D. B., Sedoc, J., DeRubeis, R. J., Willer, R., & Eichstaedt, J. C. (2024). Large language models could change the future of behavioral healthcare: A proposal for responsible development and evaluation. npj Mental Health Research, 3, Article 12. https://doi.org/10.1038/s44184-024-00056-z

Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt-Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: Current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality. World Psychiatry, 20(3), 318–335. https://doi.org/10.1002/wps.20883

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). AI Tools in Everyday Clinical Practice: Documentation, psychoeducation, and between-session support under the conditions of consent, data protection, and professional responsibility. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(3), 72–75.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.